要介護認定調査票・ペルソナ症例 05

要介護認定基本調査・主治医意見書・概況調査統合データファイル

1. 調査実施者および調査対象者の情報

調査対象者氏名	高橋 サダ（たかはし さだ）	**年齢 / 性別**	91歳 / 女性
要介護度	要介護4	**調査実施者**	市町村委託ケアマネジャー（主任介護支援専門員）

2. 現在受けているサービスの状況（概況調査）

【在宅利用・介護給付】訪問介護（ホームヘルプ）週4回、訪問入浴介護週2回、訪問看護週2回、短期入所生活介護月6日、福祉用具貸与（特殊寝台・車椅子）

3. 置かれている環境等（家族・居住環境・傷病等）

【家族状況】長女（62歳・独身、介護のために退職した「介護離職」状態）と二人暮らし。
【居住環境】バリアフリー化された一軒家。
【主な介護者】長女（主介護者・無職）。
【傷病・既往歴】老衰、両膝・両股関節拘縮、廃用症候群。

4. 主治医意見書（医学的記載事項）

主傷病名	老衰、両膝・両股関節拘縮、廃用症候群
傷病の経過・治療内容	高齢による老衰および長期臥床に伴い、全身の筋力低下と両下肢の高度な屈曲拘縮が進行。ほぼ寝たきり状態（全床生活）となっている。
医学的管理の必要性	経管栄養または高カロリーゼリーの摂取管理、褥瘡（床ずれ）予防のための体位変換、皮膚の保湿・清潔保持、定期的な訪問診療。
身体障害に関する意見	四肢の関節拘縮（特に両股・膝関節の高度屈曲拘縮）。自力での寝返り、起き上がり、座位保持は不可能であり、全介助を要する。
精神・認知機能の意見	意思疎通は極めて困難（発語はほぼなく、うなずきやうめき声程度）。聴力低下もあり認知機能の正確な評価は困難。
特別医療・ケアの必要性	24時間の褥瘡予防管理、口腔ケア、排泄ケア、および定期的な体位変換の医学的管理が必要不可欠。
介護に関する医学的意見	

	終日ベッド上の生活であり、すべての生活動作に全介助を要する。主介護者である長女の介護離職による孤立と心身の疲弊が深刻であるため、訪問看護・訪問入浴・ヘルパーおよびショートステイを最大限活用した支援が必須。

5. 要介護認定基本調査（全74項目）

第1群：身体機能・起居動作（全13項目）

1. 麻痺（上肢）：なし (1)
2. 麻痺（下肢）：なし (1)
3. 関節拘縮（上肢）：中等度あり (3)
4. 関節拘縮（下肢）：高度あり（屈曲拘縮） (4)
5. 寝返り：できない（全介助） (4)
6. 起き上がり：できない（全介助） (4)
7. 座位保持：できない（車椅子乗車時に体幹保持帯等が必要） (4)
8. 立位保持：不可能 (4)
9. 歩行：不可能 (4)
10. 立ち上がり：不可能 (4)
11. 片足立ち：不可能 (4)
12. 洗顔：全介助 (4)
13. 爪切り：全介助 (4)

第2群：生活機能（全12項目）

1. 移乗：全介助（2人での抱き上げ移乗） (4)
2. 移動（屋内）：全介助（車椅子またはベッド上） (4)
3. 移動（屋外）：全介助 (4)
4. 食事摂取：全介助（ペースト食および水分ゼリー） (4)
5. 排泄（トイレ動作）：全介助（オムツ着用） (4)
6. 排泄（排便コントロール）：全介助 (4)
7. 衣服着脱（上衣）：全介助 (4)
8. 衣服着脱（ズボン等）：全介助 (4)
9. 入浴：全介助（機械浴による清拭・入浴） (4)
10. 口腔清潔：全介助 (4)
11. 洗髪：全介助 (4)
12. 買い物：できない (4)

第3群：認知機能（全9項目）

1. 意思の伝達：ほとんどできない（うなずく、うめき声程度） (4)
2. 麻痺等による意思伝達の困難さ：聴力低下および発語減少 (3)
3. 短期記憶：評価不能 (4)
4. 日付の理解：わからない (4)
5. 場所の理解：わからない (4)
6. 自分の名前：かろうじて反応することがある (3)
7. 生年月日：わからない (4)
8. 同行者の認識：長女のことは何となく認識 (2)

9. 徘徊：なし (1)

第4群：精神・行動障害（全15項目）

1. 薬の過量服薬：なし (1)
2. 収集癖：なし (1)
3. 落ち着きのない行動：なし (1)
4. 失敗に対するこだわり：なし (1)
5. 外出先での迷子：なし (1)
6. 介護への抵抗：なし（体位変換時に呻吟することあり） (2)
7. 羞恥心の喪失：該当（寝たきりのため全介助） (3)
8. 不潔行為：なし (1)
9. 異食：なし (1)
10. 幻覚・妄想：なし (1)
11. 夜間不穏：なし (1)
12. 大声を出す：なし (1)
13. 徘徊：なし (1)
14. 興奮状態：なし (1)
15. 暴力行為：なし (1)

第5群：社会生活への適応（全6項目）

1. 薬の管理：できない (4)
2. 金銭管理：できない (4)
3. 簡単な調理：できない (4)
4. 電話の利用：できない (4)
5. 社会的交流：できない (4)
6. 日常の意思決定：できない (4)

6. 特記事項（総合所見・ケアマネジメント留意点）

91歳、寝たきり状態で食事・排泄・入浴のすべてに全介助が必要。主介護者の長女は介護離職をしており、24時間体制の介護による身体的疲弊および社会的孤立が深刻。レスパイトケアの充実、介護記録音声入力アプリ、家族介護者支援コミュニティの検証に合致するケース。